Douleur - 90 QCM

Cochez le nombre annoncé de réponses parmi A à E. Une à trois réponses exactes par question. La grille et les 450 justifications suivent les questions.

Q01 Quelles affirmations décrivent la douleur ? (2 réponses exactes)

Facile - Comprendre la douleur

- ☐ A. Elle se mesure uniquement par les constantes vitales.
- ☐ B. Elle est toujours proportionnelle à la taille de la lésion.
- ☐ C. Elle est identique chez deux personnes ayant la même maladie.
- ☐ D. Elle comporte une dimension sensorielle et émotionnelle.
- ☐ E. Elle peut exister sans lésion visible.

Q02 Quelle proposition distingue la nociception de la douleur ? (1 réponse exacte)

Facile - Comprendre la douleur

- ☐ A. La nociception désigne le traitement nerveux des stimulations nocives.
- ☐ B. Une douleur exige toujours un nocicepteur périphérique activé par une plaie.
- ☐ C. Nociception et douleur sont deux synonymes stricts.
- ☐ D. La nociception désigne seulement la peur de souffrir.
- ☐ E. Toute activité nociceptive mesure directement une intensité consciente.

Q03 Quels éléments explorent la composante sensorielle de la douleur ? (3 réponses exactes)

Facile - Comprendre la douleur

- ☐ A. Le souvenir d'un soin pénible.
- ☐ B. La localisation.
- ☐ C. L'intensité.
- ☐ D. Le type, par exemple brûlure ou décharge.
- ☐ E. La peur de devenir dépendant.

Q04 À propos des composantes émotionnelle et cognitive, quelles affirmations sont justes ? (2 réponses exactes)

Moyen - Comprendre la douleur

- ☐ A. Un souvenir douloureux prouve que la douleur actuelle est imaginaire.
- ☐ B. L'anxiété peut participer au vécu émotionnel.
- ☐ C. La composante cognitive se limite au score numérique.
- ☐ D. Une émotion intense démontre une lésion grave.
- ☐ E. Les attentes et les souvenirs participent à la dimension cognitive.

Q05 Un patient sourit malgré une EN à 8/10. Quelles attitudes sont adaptées ? (2 réponses exactes)

Moyen - Comprendre la douleur

- ☐ A. Remplacer son score par une estimation fondée sur son visage.
- ☐ B. Comparer sa réaction à celle du voisin de chambre.
- ☐ C. Conclure à une simulation.
- ☐ D. Prendre en compte son score et préciser le contexte.
- ☐ E. Explorer les autres composantes et les signes cliniques.

Q06 Quel repère permet de parler de douleur chronique ? (1 réponse exacte)

Facile - Comprendre la douleur

- ☐ A. Un mécanisme obligatoirement neuropathique.
- ☐ B. Un début datant obligatoirement de plus de six mois.
- ☐ C. Un score toujours supérieur à 7/10.
- ☐ D. L'absence obligatoire de toute maladie organique.
- ☐ E. Une douleur persistante ou récidivante au-delà de trois mois.

Q07 Quelles propositions sur les responsabilités infirmières face à la douleur sont exactes ? (3 réponses exactes)

Moyen - Comprendre la douleur

- ☐ A. L'attente d'une décision médicale supprime tout rôle propre.
- ☐ B. Le droit au soulagement autorise toute augmentation de dose de sa propre initiative.
- ☐ C. Évaluer, installer, prévenir, surveiller et transmettre participent au rôle propre.
- ☐ D. Le soulagement de la douleur est un droit du patient.
- ☐ E. L'application d'un protocole antalgique exige d'en vérifier le cadre écrit, daté, signé et intégré au dossier.

Q08 Quelles propositions distinguent les mécanismes nociceptif et neuropathique ? (2 réponses exactes)

Facile - Comprendre la douleur

- ☐ A. Une atteinte tissulaire non nerveuse activant les nocicepteurs peut produire une douleur nociceptive.
- ☐ B. L'intensité seule permet d'identifier le mécanisme.
- ☐ C. Toute douleur persistante depuis plus de trois mois est neuropathique.
- ☐ D. L'influence de l'anxiété démontre une douleur imaginaire.
- ☐ E. Une douleur neuropathique est causée par une lésion ou une maladie du système somatosensoriel.

Q09 À propos de douleur nociplastique et de mécanismes mixtes, quelles affirmations sont exactes ? (2 réponses exactes)

Difficile - Comprendre la douleur

- ☐ A. Une douleur mixte interdit toute approche non médicamenteuse.
- ☐ B. Nociplastique signifie douleur inventée.
- ☐ C. L'influence de l'anxiété démontre un mécanisme exclusivement psychologique.
- ☐ D. Une nociception altérée peut participer à une douleur nociplastique.
- ☐ E. Plusieurs mécanismes peuvent coexister chez une même personne.

Q10 Une toilette déclenche une douleur prévisible. Quelles propositions sont adaptées ? (2 réponses exactes)

Facile - Comprendre la douleur

- ☐ A. Elle impose le même médicament à tous les patients.
- ☐ B. Elle constitue un mécanisme nerveux distinct de nociceptif et neuropathique.
- ☐ C. Elle peut être qualifiée de douleur induite par le soin.
- ☐ D. Son caractère prévisible justifie de ne pas l'évaluer.
- ☐ E. Elle demande une stratégie de prévention.

Q11 À quelle étape correspond la transformation d'un stimulus nocif en signal électrique ? (1 réponse exacte)

Facile - Comprendre la douleur

- ☐ A. La traçabilité.
- ☐ B. Le verrouillage.
- ☐ C. La transduction.
- ☐ D. La perception.
- ☐ E. La biodisponibilité.

Q12 Quelles propositions décrivent le traitement du message nociceptif ? (3 réponses exactes)

Moyen - Comprendre la douleur

- ☐ A. La modulation peut freiner ou faciliter la transmission.
- ☐ B. Les afférences gagnent la corne dorsale médullaire.
- ☐ C. Des réseaux cérébraux intègrent les dimensions de l'expérience.
- ☐ D. Le message contourne toujours la moelle épinière.
- ☐ E. La modulation intervient uniquement après la perception consciente.

Q13 Quelles caractéristiques des fibres Aδ et C sont exactes ? (2 réponses exactes)

Facile - Comprendre la douleur

- ☐ A. Les fibres Aδ sont myélinisées et plus rapides que les fibres C.
- ☐ B. Les fibres C transmettent uniquement le tact fin.
- ☐ C. Les fibres Aδ sont les grosses fibres tactiles Aβ.
- ☐ D. Les fibres C sont non myélinisées et plus lentes.
- ☐ E. Toute douleur tardive démontre à elle seule une neuropathie.

Q14 Quelles affirmations correspondent au modèle simplifié du gate control ? (2 réponses exactes)

Moyen - Comprendre la douleur

- ☐ A. Les afférences tactiles Aβ peuvent recruter des circuits inhibiteurs médullaires.
- ☐ B. Le modèle dispense d'alerter devant une douleur thoracique nouvelle.
- ☐ C. Frotter supprime nécessairement la cause de la douleur.
- ☐ D. Un frottement doux peut parfois réduire une douleur après un petit choc.
- ☐ E. Les fibres Aβ sont normalement les petites fibres nociceptives lentes.

Q15 Quelles affirmations sur la sensibilisation sont exactes ? (2 réponses exactes)

Moyen - Comprendre la douleur

- ☐ A. Des modifications centrales peuvent entretenir une hypersensibilité.
- ☐ B. Les prostaglandines sont sans lien avec la nociception.
- ☐ C. Des médiateurs inflammatoires peuvent abaisser le seuil des nocicepteurs.
- ☐ D. Une sensibilisation signifie toujours une lésion nerveuse.
- ☐ E. L'hypersensibilité prouve une exagération volontaire.

Q16 Quelles propositions distinguent allodynie et hyperalgésie ? (2 réponses exactes)

Facile - Comprendre la douleur

- ☐ A. Les deux termes décrivent uniquement une durée de douleur.
- ☐ B. L'allodynie correspond à une absence totale de sensibilité.
- ☐ C. L'hyperalgésie est un synonyme d'absence de douleur.
- ☐ D. La douleur au contact d'un drap peut être une allodynie.
- ☐ E. L'hyperalgésie est une réponse accrue à un stimulus normalement douloureux.

Q17 Quelles propositions sur le réflexe de retrait sont exactes ? (3 réponses exactes)

Moyen - Comprendre la douleur

- ☐ A. Le ganglion spinal est la synapse motrice du réflexe.
- ☐ B. L'absence de retrait exclut une douleur.
- ☐ C. La racine dorsale apporte l'information sensitive.
- ☐ D. Le retrait ne mesure pas à lui seul l'intensité consciente.
- ☐ E. Il peut précéder une décision volontaire.

Q18 Une douleur d'origine viscérale peut être ressentie dans une zone cutanée distante. Quelles propositions l'expliquent ? (2 réponses exactes)

Difficile - Comprendre la douleur

- ☐ A. La zone ressentie n'est pas nécessairement le siège d'une lésion locale.
- ☐ B. La localisation permet à elle seule de diagnostiquer l'organe en cause.
- ☐ C. Des afférences viscérales et somatiques peuvent converger sur un neurone médullaire.
- ☐ D. Cette convergence est identique au verrouillage d'une PCA.
- ☐ E. Toute douleur du bras est une douleur cardiaque.

Q19 Quelles associations correspondent au mémo TILT ? (3 réponses exactes)

Facile - Évaluer et réévaluer

- ☐ A. I : identité du prescripteur.
- ☐ B. Dernier T : traitement uniquement.
- ☐ C. L : localisation.
- ☐ D. Dernier T : type.
- ☐ E. Premier T : temps.

Q20 Que faut-il ajouter à TILT pour une évaluation globale ? (3 réponses exactes)

Moyen - Évaluer et réévaluer

- ☐ A. Les inquiétudes, attentes et expériences antérieures.
- ☐ B. Une comparaison systématique avec la tolérance des autres patients.
- ☐ C. Les prises déjà effectuées et leur effet.
- ☐ D. Le retentissement sur le sommeil et les activités.
- ☐ E. Un diagnostic définitif fondé uniquement sur le mot brûlure.

Q21 Quelles affirmations décrivent l'échelle numérique ? (2 réponses exactes)

Facile - Évaluer et réévaluer

- ☐ A. L'EN décrit à elle seule les quatre composantes.
- ☐ B. Le contexte de mesure doit être précisé.
- ☐ C. Le soignant choisit le chiffre selon les grimaces.
- ☐ D. Un chiffre suffit à choisir automatiquement un opioïde.
- ☐ E. Le patient choisit habituellement un nombre de 0 à 10.

Q22 Quelles affirmations sur l'EVA sont justes ? (2 réponses exactes)

Moyen - Évaluer et réévaluer

- ☐ A. Toute EVA exprimée sur 10 est nécessairement fausse.
- ☐ B. L'EVA est toujours une liste de qualificatifs verbaux.
- ☐ C. Une valeur EVA se convertit sans précaution en tout autre score.
- ☐ D. Le patient positionne un repère sur une ligne entre deux extrêmes.
- ☐ E. L'unité et la présentation doivent être précisées.

Q23 Quelles propositions sur les outils d'auto-évaluation sont exactes ? (2 réponses exactes)

Moyen - Évaluer et réévaluer

- ☐ A. Une échelle de visages mesure la douleur selon sa consigne validée.
- ☐ B. La tristesse du visage doit remplacer la consigne d'une échelle de douleur.
- ☐ C. L'EVS propose des qualificatifs d'intensité.
- ☐ D. Tous les patients comprennent spontanément tous les outils.
- ☐ E. Changer de version d'EVS ne nécessite aucune trace.

Q24 Une personne âgée présente un trouble neurocognitif modéré. Quelles attitudes sont adaptées ? (2 réponses exactes)

Moyen - Évaluer et réévaluer

- ☐ A. Choisir l'échelle uniquement selon l'âge civil.
- ☐ B. Vérifier audition, vision et compréhension.
- ☐ C. Demander uniquement au proche de fixer l'intensité.
- ☐ D. Essayer une auto-évaluation simple et expliquée.
- ☐ E. Écarter toute parole du patient dès le diagnostic cognitif connu.

Q25 Quels domaines appartiennent à ALGOPLUS ? (3 réponses exactes)

Facile - Évaluer et réévaluer

- ☐ A. La dose antalgique et la durée de prescription.
- ☐ B. La créatinine et le poids.
- ☐ C. Les plaintes.
- ☐ D. Le visage et le regard.
- ☐ E. Le corps et le comportement.

Q26 Chez une personne âgée non communicante verbalement, quelles affirmations sur ALGOPLUS sont justes ? (2 réponses exactes)

Moyen - Évaluer et réévaluer

- ☐ A. Un score d'au moins 2/5 est en faveur d'une douleur à prendre en charge.
- ☐ B. Le score se convertit directement en EN sur 10.
- ☐ C. Le total va de 0 à 5.
- ☐ D. Un score de 0 exclut définitivement toute douleur.
- ☐ E. ALGOPLUS établit à lui seul la cause de la douleur.

Q27 Quelles affirmations décrivent DOLOPLUS-2 ? (3 réponses exactes)

Facile - Évaluer et réévaluer

- ☐ A. Il comporte dix items.
- ☐ B. Il est destiné uniquement au nouveau-né.
- ☐ C. Le repère de douleur est au moins 5/30.
- ☐ D. Le total est compris entre 0 et 30.
- ☐ E. Il sert à convertir directement une EVA.

Q28 À propos d'ECPA, quelle proposition est exacte ? (1 réponse exacte)

Moyen - Évaluer et réévaluer

- ☐ A. Son score est une EN donnée par le proche.
- ☐ B. L'observation compare notamment avant et pendant le soin.
- ☐ C. ECPA permet de supprimer toute observation au repos.
- ☐ D. La grille exige seulement une pression artérielle.
- ☐ E. Un souvenir vague de la grille suffit à coter.

Q29 Quelles associations entre outils et situations sont cohérentes ? (3 réponses exactes)

Moyen - Évaluer et réévaluer

- ☐ A. DN4 : intensité de douleur du nouveau-né.
- ☐ B. EVENDOL et FLACC : outils comportementaux de l'enfant selon le contexte.
- ☐ C. EDIN : douleur prolongée chez le nouveau-né.
- ☐ D. DOLOPLUS-2 : auto-évaluation du nourrisson.
- ☐ E. DAN : douleur aiguë chez le nouveau-né.

Q30 En réanimation, un adulte ne peut pas s'auto-évaluer. Quelles propositions sont adaptées ? (2 réponses exactes)

Moyen - Évaluer et réévaluer

- ☐ A. Observer avec une grille validée et réévaluer après intervention.
- ☐ B. Utiliser BPS ou CPOT si la situation correspond à leurs conditions d'emploi.
- ☐ C. Attribuer une EN fictive à partir de la fréquence cardiaque.
- ☐ D. Conclure à l'absence de douleur du seul fait de la sédation.
- ☐ E. Utiliser un outil sans tenir compte de la population validée.

Q31 Quels éléments appartiennent au DN4 complet ? (3 réponses exactes)

Facile - Évaluer et réévaluer

- ☐ A. Une recherche d'hypoesthésie au tact ou à la piqûre.
- ☐ B. Une note de satisfaction sur le repas.
- ☐ C. Une mesure obligatoire de la pression artérielle.
- ☐ D. Des qualificatifs comme brûlure et décharges électriques.
- ☐ E. La douleur provoquée ou majorée par le frottement.

Q32 Quelles interprétations d'un DN4 complet sont correctes ? (2 réponses exactes)

Moyen - Évaluer et réévaluer

- ☐ A. Un DN4 à 6/10 signifie une intensité douloureuse de 6/10.
- ☐ B. Le résultat doit être intégré à l'évaluation clinique.
- ☐ C. Trois items recueillis suffisent à annoncer un DN4 complet.
- ☐ D. Un total d'au moins 4/10 rend probable une composante neuropathique.
- ☐ E. Un résultat positif autorise l'IDE à prescrire seul une nouvelle molécule.

Q33 Quelles conditions rendent une réévaluation interprétable ? (3 réponses exactes)

Moyen - Évaluer et réévaluer

- ☐ A. Attendre la relève malgré une dégradation clinique aiguë.
- ☐ B. Utiliser si possible le même outil.
- ☐ C. Comparer uniquement un score initial au lever à un score final au repos.
- ☐ D. Comparer des situations semblables, par exemple le même mouvement.
- ☐ E. Évaluer aussi fonction et tolérance.

Q34 Quelle distinction entre délai d'action et intervalle entre prises est correcte ? (2 réponses exactes)

Difficile - Évaluer et réévaluer

- ☐ A. Le délai d'action aide à programmer la réévaluation.
- ☐ B. Le même délai convient à tous les antalgiques et à toutes les voies.
- ☐ C. Le délai d'action autorise automatiquement une nouvelle dose.
- ☐ D. L'intervalle entre prises évite des administrations trop rapprochées.
- ☐ E. Une aggravation doit attendre le délai théorique avant toute observation.

Q35 Quels éléments rendent une transmission douleur exploitable ? (3 réponses exactes)

Moyen - Traçabilité et relais

- ☐ A. L'action et l'heure réellement effectuées.
- ☐ B. L'outil, le score et les conditions de mesure.
- ☐ C. Une cause supposée présentée comme un fait certain.
- ☐ D. Le résultat, la tolérance et la suite prévue.
- ☐ E. La mention isolée « antalgique donné » sans dose ni voie.

Q36 Quelles propositions sur les voies et dispositifs sont exactes ? (2 réponses exactes)

Facile - Sécurité des antalgiques

- ☐ A. Un patch peut avoir un effet systémique.
- ☐ B. La voie orale suppose notamment une déglutition et une conscience compatibles.
- ☐ C. La voie IV supprime le besoin de surveillance.
- ☐ D. Toute ampoule peut être administrée par toute voie.
- ☐ E. PCA désigne une voie anatomique.

Q37 Quelle affirmation sur la biodisponibilité absolue est exacte ? (1 réponse exacte)

Facile - Sécurité des antalgiques

- ☐ A. Elle permet de transposer toutes les doses d'une voie à l'autre.
- ☐ B. Elle est de 100 % par voie IV.
- ☐ C. Elle désigne uniquement le temps avant soulagement.
- ☐ D. Elle est toujours de 100 % par voie orale.
- ☐ E. Elle ne concerne que les antalgiques opioïdes.

Q38 Quelles vérifications complètent les cinq B avant un antalgique ? (3 réponses exactes)

Moyen - Sécurité des antalgiques

- ☐ A. Dernières prises et cumul de plusieurs spécialités.
- ☐ B. Allergies, terrain rénal ou hépatique et interactions.
- ☐ C. La couleur de la boîte comme seul contrôle d'identité.
- ☐ D. Surveillance prévue et traçabilité.
- ☐ E. L'habitude du service malgré une prescription illisible.

Q39 Quelles propositions sur les formes LI et LP sont justes ? (2 réponses exactes)

Moyen - Sécurité des antalgiques

- ☐ A. Une forme LP peut servir au traitement de fond selon prescription.
- ☐ B. Une forme LP est nécessairement adaptée à une titration rapide.
- ☐ C. L'écrasement doit être vérifié spécialité par spécialité.
- ☐ D. Toute gélule LP peut être ouverte puis broyée.
- ☐ E. LI et LP sont interchangeables sans vérification.

Q40 Quelles associations entre famille et exemple sont correctes ? (3 réponses exactes)

Facile - Sécurité des antalgiques

- ☐ A. Palier II : codéine ou tramadol.
- ☐ B. Néfopam : antagoniste opioïde.
- ☐ C. Palier III : morphine ou fentanyl.
- ☐ D. Un palier indique à lui seul le mécanisme de la douleur.
- ☐ E. Palier I : paracétamol.

Q41 Quelles propositions sur les associations antalgiques sont adaptées ? (2 réponses exactes)

Difficile - Sécurité des antalgiques

- ☐ A. Un non-opioïde peut être associé à un opioïde selon indication et prescription.
- ☐ B. Associer automatiquement les paliers II et III garantit une meilleure sécurité.
- ☐ C. Toute douleur neuropathique impose seulement d'augmenter le palier.
- ☐ D. Un opioïde faible n'expose pas à une dépression respiratoire.
- ☐ E. Les doublons et le cumul de sédation doivent être recherchés.

Q42 Une personne a reçu 1 g de paracétamol trois fois, puis une association contenant 500 mg de paracétamol. Quelles affirmations sont justes ? (2 réponses exactes)

Moyen - Sécurité des antalgiques

- ☐ A. L'association doit être incluse dans le total.
- ☐ B. Le total reste à 3 g car l'association porte un autre nom.
- ☐ C. Ce calcul autorise automatiquement une nouvelle dose.
- ☐ D. Le risque principal d'un excès est uniquement la constipation.
- ☐ E. Le cumul de paracétamol est de 3,5 g.

Q43 Une personne fragile pèse 44 kg et mange peu. Quelles attitudes sont adaptées avant du paracétamol ? (2 réponses exactes)

Difficile - Sécurité des antalgiques

- ☐ A. Déduire la dose du seul âge.
- ☐ B. Appliquer systématiquement 4 g par jour.
- ☐ C. Ignorer les associations médicamenteuses si le patient est hospitalisé.
- ☐ D. Rapprocher la prescription du RCP de la spécialité et demander clarification si besoin.
- ☐ E. Vérifier poids, nutrition, fonctions rénale et hépatique.

Q44 Un surdosage de paracétamol est suspecté. Quelles propositions sont exactes ? (2 réponses exactes)

Moyen - Sécurité des antalgiques

- ☐ A. La naloxone est l'antidote du paracétamol.
- ☐ B. Un délai déjà long dispense de demander un avis.
- ☐ C. Une alerte médicale et un avis toxicologique adaptés sont urgents.
- ☐ D. La N-acétylcystéine est un antidote utilisé selon protocole.
- ☐ E. L'absence immédiate de symptômes élimine le risque.

Q45 Quels risques doivent être recherchés avant un AINS ? (3 réponses exactes)

Moyen - Sécurité des antalgiques

- ☐ A. L'inutilité de connaître la molécule exacte.
- ☐ B. La prise d'un autre AINS ou de médicaments augmentant le saignement.
- ☐ C. Le risque digestif et hémorragique.
- ☐ D. L'absence de risque si le médicament est de palier I.
- ☐ E. Le risque rénal, notamment en cas de déshydratation.

Q46 Une personne prend de l'aspirine à faible dose avant une intervention programmée. Quelles affirmations sont adaptées ? (2 réponses exactes)

Difficile - Sécurité des antalgiques

- ☐ A. L'IDE doit l'arrêter systématiquement de sa propre initiative.
- ☐ B. L'effet sur les plaquettes est sans conséquence pour le saignement.
- ☐ C. La conduite périopératoire demande une décision médicale coordonnée.
- ☐ D. L'indication peut être antiagrégante cardiovasculaire.
- ☐ E. Le traitement peut être ignoré parce qu'il est ancien.

Q47 Quelles propositions sur les présentations de néfopam sont exactes ? (2 réponses exactes)

Difficile - Sécurité des antalgiques

- ☐ A. Une dose orale et une dose injectable sont toujours équivalentes.
- ☐ B. L'existence d'un comprimé autorise à avaler toute ampoule injectable.
- ☐ C. Le néfopam prévient le sevrage d'un opioïde.
- ☐ D. Le néfopam est un antalgique central non opioïde.
- ☐ E. Les formes orale et injectable ont leurs propres RCP.

Q48 Quelles données imposent une vérification particulière avant le néfopam ? (3 réponses exactes)

Moyen - Sécurité des antalgiques

- ☐ A. Des antécédents de convulsions.
- ☐ B. Un risque de rétention urinaire ou de glaucome par fermeture de l'angle.
- ☐ C. L'âge avancé et les fonctions rénale ou hépatique.
- ☐ D. Son caractère non opioïde, qui garantit une absence de confusion.
- ☐ E. L'absence de nécessité de surveiller fréquence cardiaque et tolérance.

Q49 Quelles affirmations sur le tramadol sont justes ? (2 réponses exactes)

Moyen - Sécurité des antalgiques

- ☐ A. Il a une action opioïde et monoaminergique.
- ☐ B. Il ne peut pas entraîner de dépression respiratoire.
- ☐ C. Toutes ses formulations ont un plafond identique sans adaptation.
- ☐ D. Un traitement prolongé se stoppe toujours brutalement sans avis.
- ☐ E. Des convulsions et un syndrome sérotoninergique sont possibles.

Q50 Quelles affirmations concernant la codéine sont exactes ? (2 réponses exactes)

Moyen - Sécurité des antalgiques

- ☐ A. Elle est utilisable sans restriction pendant l'allaitement.
- ☐ B. Elle peut se trouver dans une association contenant du paracétamol.
- ☐ C. La même dose produit le même effet chez tout le monde.
- ☐ D. L'absence de soulagement autorise à doubler soi-même la dose.
- ☐ E. Elle est partiellement transformée en morphine par CYP2D6.

Q51 Quelles associations pharmacologiques sont correctes ? (3 réponses exactes)

Facile - Sécurité des antalgiques

- ☐ A. Naloxone : antagoniste opioïde.
- ☐ B. Morphine : agoniste opioïde.
- ☐ C. Morphine : antagoniste des récepteurs μ.
- ☐ D. Naloxone : antidote du paracétamol.
- ☐ E. Narcan : nom de spécialité de naloxone.

Q52 Quelles surveillances sont importantes sous morphine ? (3 réponses exactes)

Moyen - Sécurité des antalgiques

- ☐ A. Transit, nausées et rétention urinaire.
- ☐ B. Respiration et réveillabilité.
- ☐ C. La seule saturation en oxygène suffit à toute la surveillance.
- ☐ D. Une douleur soulagée prouve l'absence d'effet indésirable.
- ☐ E. Fonction rénale et autres dépresseurs centraux.

Q53 Une personne sous opioïde est très somnolente et respire lentement. Quelles actions sont prioritaires ? (3 réponses exactes)

Difficile - Sécurité des antalgiques

- ☐ A. Redonner un bolus pour prévenir le retour de la douleur.
- ☐ B. Poursuivre la surveillance après une éventuelle naloxone.
- ☐ C. Alerter immédiatement et sécuriser la respiration selon le cadre d'urgence.
- ☐ D. Appliquer le protocole adapté et surveiller de façon rapprochée.
- ☐ E. La laisser dormir jusqu'à la prochaine relève.

Q54 Quelles conditions correspondent à une PCA standard ? (2 réponses exactes)

Moyen - Sécurité des antalgiques

- ☐ A. Le patient comprend l'utilisation et appuie lui-même.
- ☐ B. L'IDE modifie librement les réglages pour diminuer les demandes.
- ☐ C. Produit, concentration, bolus et verrouillage correspondent à la prescription.
- ☐ D. La famille appuie quand le patient dort.
- ☐ E. Un débit continu est obligatoire dans toute PCA.

Q55 Quelles propositions décrivent la période de verrouillage d'une PCA ? (2 réponses exactes)

Difficile - Sécurité des antalgiques

- ☐ A. Le verrouillage rend tout surdosage impossible.
- ☐ B. Il supprime la nécessité de surveiller vigilance et respiration.
- ☐ C. Les demandes et doses délivrées doivent être analysées avec le soulagement.
- ☐ D. Un appui pendant le verrouillage ne délivre pas de nouveau bolus.
- ☐ E. Il a une durée universelle identique pour tous les patients.

Q56 Quelles affirmations sur les co-antalgiques sont exactes ? (2 réponses exactes)

Moyen - Sécurité des antalgiques

- ☐ A. Certains antiépileptiques peuvent traiter une douleur neuropathique.
- ☐ B. Ils remplacent toute évaluation fonctionnelle.
- ☐ C. Leur prescription prouve une douleur imaginaire.
- ☐ D. Certains antidépresseurs peuvent être prescrits à visée antalgique.
- ☐ E. Leur effet est nécessairement immédiat et identique pour tous.

Q57 Quelles vigilances concernent gabapentine ou prégabaline ? (2 réponses exactes)

Moyen - Sécurité des antalgiques

- ☐ A. Le score de douleur suffit à vérifier leur tolérance.
- ☐ B. Somnolence et vertiges.
- ☐ C. L'arrêt systématique brutal dès que la douleur baisse.
- ☐ D. Fonction rénale et interactions selon le produit.
- ☐ E. L'absence de risque puisqu'il ne s'agit pas de morphine.

Q58 Quelles propositions sur les traitements locaux et les co-antalgiques sont exactes ? (2 réponses exactes)

Difficile - Sécurité des antalgiques

- ☐ A. Un corticoïde est systématique dans toute neuropathie.
- ☐ B. Un traitement local dispense de suivre efficacité et tolérance.
- ☐ C. Le choix dépend du territoire, du terrain et du bénéfice-risque.
- ☐ D. Une recommandation neuropathique s'applique à toute douleur chronique primaire.
- ☐ E. Lidocaïne ou capsaïcine peuvent être indiquées dans certaines douleurs neuropathiques périphériques localisées.

Q59 Que préparer avant un soin potentiellement douloureux ? (3 réponses exactes)

Facile - Prévenir les douleurs des soins

- ☐ A. Promettre une absence certaine de douleur.
- ☐ B. Le matériel et l'installation pour limiter les gestes inutiles.
- ☐ C. Attendre la fin du geste pour rechercher toute douleur.
- ☐ D. Une explication compréhensible et l'accord de la personne.
- ☐ E. Une évaluation et une stratégie antalgique adaptée.

Q60 Pendant un soin, quelles attitudes sont adaptées ? (3 réponses exactes)

Moyen - Prévenir les douleurs des soins

- ☐ A. Poursuivre systématiquement malgré une altération de conscience.
- ☐ B. Surveiller les signes d'intolérance et réévaluer.
- ☐ C. Finir au plus vite malgré un refus sans réévaluer la situation.
- ☐ D. Adapter rythme et installation.
- ☐ E. Respecter un signal de pause convenu.

Q61 Quelles propositions sur le MEOPA sont exactes ? (3 réponses exactes)

Facile - Prévenir les douleurs des soins

- ☐ A. Il correspond à une anesthésie générale obligatoire.
- ☐ B. Il peut être utilisé pour certains actes douloureux courts selon indication et protocole.
- ☐ C. Le contact verbal, la respiration et la conscience sont surveillés.
- ☐ D. C'est un mélange équimolaire d'oxygène et de protoxyde d'azote.
- ☐ E. Sa composition dispense de vérifier les contre-indications.

Q62 Avant un topique lidocaïne-prilocaïne, quelles vérifications sont nécessaires ? (3 réponses exactes)

Moyen - Prévenir les douleurs des soins

- ☐ A. Contre-indications et risque de méthémoglobinémie selon le contexte.
- ☐ B. Âge, dose, surface et durée d'application.
- ☐ C. État cutané, site et délai nécessaire avant le geste.
- ☐ D. Appliquer un délai identique pour tous les produits et tous les actes.
- ☐ E. Supprimer l'accompagnement puisque la peau est anesthésiée.

Q63 Quelles propositions décrivent des moyens non médicamenteux adaptés ? (3 réponses exactes)

Moyen - Approches non médicamenteuses

- ☐ A. Leur effet doit être réévalué.
- ☐ B. Respiration, musique ou distraction peuvent être proposées avec l'accord du patient.
- ☐ C. Toute technique convient à tous les patients.
- ☐ D. Leur utilisation autorise à retarder une alerte devant un signe de gravité.
- ☐ E. Une installation antalgique et une mobilisation fractionnée peuvent être utiles.

Q64 Quelles affirmations sur placebo, nocebo et relation de soin sont exactes ? (2 réponses exactes)

Difficile - Approches non médicamenteuses

- ☐ A. Un effet placebo prouve qu'aucun médicament n'agit pharmacologiquement.
- ☐ B. Une information honnête aide à préserver la confiance.
- ☐ C. Les attentes et le contexte peuvent modifier le vécu douloureux.
- ☐ D. Tromper le patient est nécessaire pour le rassurer.
- ☐ E. Un effet contextuel prouve que la douleur était imaginaire.

Q65 Quel objectif permet de suivre un bénéfice fonctionnel après chirurgie ? (1 réponse exacte)

Moyen - Évaluer et réévaluer

- ☐ A. Ne plus poser de question sur la douleur.
- ☐ B. Pouvoir tousser et se redresser plus facilement avec une tolérance satisfaisante.
- ☐ C. Obtenir seulement une baisse du score au repos.
- ☐ D. Dormir sans possibilité d'être réveillé.
- ☐ E. Atteindre obligatoirement zéro douleur avant toute décision.

Q66 M. Martin est à J0 d'une chirurgie digestive. Il dit « ça va, j'ai surtout mal quand je bouge » et serre les dents au changement de position. Quelles interprétations sont justes ? (2 réponses exactes)

Moyen - Situations cliniques

- ☐ A. Le « ça va » permet d'exclure toute douleur.
- ☐ B. Il existe un signe verbalisé de douleur au mouvement.
- ☐ C. Son comportement prouve une simulation.
- ☐ D. On peut déduire directement une EN à 8/10.
- ☐ E. Le serrement des dents est un signe observable.

Q67 M. Martin dit que la douleur est « moins forte allongé » mais reste présente. Quelles propositions sont justes ? (2 réponses exactes)

Difficile - Situations cliniques

- ☐ A. Une douleur dite diffuse renseigne uniquement sa durée.
- ☐ B. Le mot « tire » fournit directement un score d'intensité.
- ☐ C. Il faut préciser les moments, mouvements et facteurs calmants.
- ☐ D. Une variation d'intensité prouve que la douleur est intermittente.
- ☐ E. Une douleur peut être continue tout en variant d'intensité.

Q68 M. Martin souhaite aller aux toilettes et craint la douleur. Quelles actions sont adaptées ? (3 réponses exactes)

Difficile - Situations cliniques

- ☐ A. Si le besoin est urgent, rechercher avec lui une solution de proximité adaptée.
- ☐ B. Le faire marcher immédiatement sans aide pour tester sa volonté.
- ☐ C. Si le besoin permet d'attendre, anticiper une antalgie prescrite et son délai d'action.
- ☐ D. Vérifier les conditions du lever et la tolérance clinique.
- ☐ E. Attendre obligatoirement le même délai pour tout médicament et toute situation.

Q69 Après traitement, M. Martin rapporte 2/10 au repos et 6/10 au lever, contre 7/10 au mouvement auparavant. Quelles conclusions sont adaptées ? (3 réponses exactes)

Difficile - Situations cliniques

- ☐ A. La douleur au mouvement persiste malgré une amélioration modeste de 7 à 6/10.
- ☐ B. Il faut vérifier délai, prises et stratégie de mobilisation puis transmettre si l'objectif reste insuffisant.
- ☐ C. Le résultat au repos ne suffit pas à démontrer une bonne antalgie au lever.
- ☐ D. On peut chiffrer l'amélioration au repos sans score initial de repos.
- ☐ E. Le passage de 7 à 2 prouve cinq points gagnés au même mouvement.

Q70 Après chirurgie, une douleur devient brutale et croissante avec difficulté respiratoire. Quelles actions sont prioritaires ? (2 réponses exactes)

Difficile - Situations cliniques

- ☐ A. Attribuer forcément la douleur à l'incision habituelle.
- ☐ B. Se limiter à une technique de distraction.
- ☐ C. Rechercher les signes de gravité et alerter immédiatement.
- ☐ D. Sécuriser la personne et surveiller selon son état.
- ☐ E. Attendre systématiquement la prochaine prise prescrite.

Q71 M. L. décrit des brûlures et décharges aux pieds, avec sommeil perturbé et marche diminuée. Quelles propositions sont adaptées ? (3 réponses exactes)

Difficile - Situations cliniques

- ☐ A. Examiner et transmettre l'état cutané, le territoire et les éventuels déficits selon ses compétences.
- ☐ B. Attribuer automatiquement tout symptôme au diabète connu.
- ☐ C. Suivre sommeil, marche et tolérance en plus du score.
- ☐ D. Conclure que le score remplace l'examen des pieds.
- ☐ E. Rechercher une composante neuropathique par une évaluation appropriée.

Q72 Mme R., 86 ans, dit avoir mal depuis des mois. Son fils estime qu'elle « se plaint toujours ». Quelles attitudes sont adaptées ? (2 réponses exactes)

Moyen - Évaluer et réévaluer

- ☐ A. Déduire qu'elle souffre forcément plus qu'une personne qui parle peu.
- ☐ B. Recueillir les observations du proche sur les changements habituels.
- ☐ C. Conclure que la douleur est normale à son âge.
- ☐ D. Écarter sa parole au profit de celle de son fils.
- ☐ E. Accueillir sa plainte et caractériser la douleur.

Q73 Mme Jeanne B., 82 ans, a une gonarthrose douloureuse depuis huit mois, habituellement cotée 4/10. Après une chute ce matin, le genou droit est coté 8/10. Quelles analyses sont justes ? (3 réponses exactes)

Moyen - TD3 - douleur aiguë et chronique

- ☐ A. Un épisode aigu peut se superposer à la douleur chronique.
- ☐ B. Le score à 8 prouve à lui seul une fracture.
- ☐ C. L'outil et les conditions doivent être précisés avant de comparer les valeurs.
- ☐ D. La chute impose de rechercher une nouvelle cause traumatique.
- ☐ E. La chronicité autorise à ignorer la chute.

Q74 Après la chute de Mme Jeanne B., quelles données sont utiles au recueil ? (3 réponses exactes)

Difficile - TD3 - douleur aiguë et chronique

- ☐ A. Uniquement l'ancien diagnostic de gonarthrose.
- ☐ B. Uniquement la préférence de la famille pour un antalgique.
- ☐ C. Traitements pris, notamment ceux augmentant le risque de saignement.
- ☐ D. Circonstances de chute, malaise et éventuel choc crânien.
- ☐ E. Gonflement, déformation, appui et état du membre selon les compétences.

Q75 Mme Jeanne B. ne peut pas prendre appui après sa chute et présente une forte douleur du genou. Quelle conduite est adaptée ? (1 réponse exacte)

Difficile - TD3 - douleur aiguë et chronique

- ☐ A. Attendre plusieurs jours puisque l'arthrose est ancienne.
- ☐ B. Imposer une marche rapide pour vérifier qu'il ne s'agit que de peur.
- ☐ C. Déduire de l'absence de plainte au repos que l'appui est sans risque.
- ☐ D. Massager vigoureusement le genou avant toute évaluation.
- ☐ E. Éviter les mobilisations forcées, sécuriser et organiser l'évaluation médicale.

Q76 M. André L., 79 ans, a une lombalgie chronique à 6/10, dort mal, mange moins et a cessé la pétanque. Quelles dimensions faut-il explorer ? (3 réponses exactes)

Moyen - TD3 - retentissement

- ☐ A. Seulement le score, puisqu'il résume la qualité de vie.
- ☐ B. Le retentissement physique et nutritionnel.
- ☐ C. Le retentissement psychologique et social.
- ☐ D. Le retentissement fonctionnel et les ressources disponibles.
- ☐ E. Une dépression certaine sans autre évaluation.

Q77 Quelles propositions distinguent les composantes de la douleur de ses conséquences ? (2 réponses exactes)

Difficile - TD3 - retentissement

- ☐ A. Un bilan de retentissement remplace toute description de douleur.
- ☐ B. Les quatre composantes sont les quatre paliers OMS.
- ☐ C. Sensorielle, émotionnelle, cognitive et comportementale décrivent l'expérience douloureuse.
- ☐ D. Sommeil, relations et autonomie peuvent décrire son retentissement.
- ☐ E. Un score d'intensité décrit entièrement la composante sociale.

Q78 Quel projet est le plus adapté à M. André L., qui souhaite retrouver des activités malgré sa lombalgie ? (1 réponse exacte)

Moyen - TD3 - retentissement

- ☐ A. Choisir l'objectif sans recueillir ses préférences.
- ☐ B. Attendre uniquement un score nul avant tout projet d'activité.
- ☐ C. Imposer immédiatement la reprise intégrale de ses activités antérieures.
- ☐ D. Choisir avec lui une activité importante, un point de départ et un moment de bilan.
- ☐ E. Promettre la disparition certaine de toute douleur en une journée.

Q79 Mme Madeleine P., 88 ans, habituellement calme, devient en quelques heures agitée, grimaçante aux mobilisations et moins communicante. Quelles interprétations sont adaptées ? (3 réponses exactes)

Difficile - TD3 - troubles cognitifs

- ☐ A. Il faut rechercher aussi d'autres causes de dégradation aiguë.
- ☐ B. Ces seuls signes prouvent la localisation et l'étiologie exactes.
- ☐ C. L'apparition récente doit être rapidement transmise pour évaluation.
- ☐ D. Tout s'explique forcément par son trouble neurocognitif ancien.
- ☐ E. Une douleur est possible même sans plainte explicite.

Q80 Mme Madeleine P. répond « non, laissez-moi » à la toilette. Quelles démarches sont adaptées ? (2 réponses exactes)

Moyen - TD3 - troubles cognitifs

- ☐ A. Multiplier les gestes douloureux pour obtenir une réaction.
- ☐ B. Renoncer définitivement à toute évaluation.
- ☐ C. Si l'auto-évaluation n'est pas fiable, utiliser une grille comportementale adaptée.
- ☐ D. Approcher calmement avec une question courte et un outil simple si compris.
- ☐ E. Interpréter le refus comme une preuve d'absence de douleur.

Q81 Une vignette décrit agitation et grimaces de Mme Madeleine sans cotation complète d'ALGOPLUS. Quelles propositions sont justes ? (2 réponses exactes)

Difficile - TD3 - troubles cognitifs

- ☐ A. L'équipe et les proches peuvent préciser le comportement habituel.
- ☐ B. La grille remplace la recherche d'une cause.
- ☐ C. On ne peut pas annoncer un score exact à partir de ces seuls éléments.
- ☐ D. Le proche peut transformer directement une inquiétude en EN.
- ☐ E. Deux mots évocateurs autorisent automatiquement un score de 5/5.

Q82 Quelles interventions relationnelles et environnementales peuvent aider Mme Madeleine ? (3 réponses exactes)

Moyen - TD3 - troubles cognitifs

- ☐ A. Préserver repères et aides sensorielles en limitant le bruit.
- ☐ B. Ignorer les refus pour terminer toute la toilette sans interruption.
- ☐ C. Expliquer un geste à la fois et respecter son rythme.
- ☐ D. Lui permettre de participer selon ses capacités et proposer des pauses.
- ☐ E. Écarter toute préférence parce qu'elle a un trouble cognitif.

Q83 Mme B., 84 ans, reçoit un « antalgique de palier I » dont le nom n'est pas donné. Elle a une insuffisance rénale et une somnolence. Quelles propositions sont adaptées ? (2 réponses exactes)

Difficile - TD3 - médicaments et fragilité

- ☐ A. Identifier la molécule, la présentation et la prescription avant de conclure.
- ☐ B. Déduire qu'elle reçoit forcément du paracétamol à 1 g.
- ☐ C. Attribuer avec certitude la somnolence à l'antalgique.
- ☐ D. Considérer tout palier I comme sans danger rénal.
- ☐ E. Vérifier les autres traitements et les prises réelles.

Q84 Chez Mme B., 84 ans, insuffisante rénale, peu alimentée et polymédiquée, quelles vérifications sont pertinentes ? (3 réponses exactes)

Difficile - TD3 - médicaments et fragilité

- ☐ A. Absence de contrôle si la prescription date de plusieurs semaines.
- ☐ B. Application automatique du plafond adulte standard.
- ☐ C. Vigilance et sécurité de la déglutition.
- ☐ D. Poids, nutrition, hydratation et fonctions d'élimination.
- ☐ E. Cumul des substances, interactions et automédication.

Q85 Mme B. présente une somnolence inhabituelle avant l'administration prévue. Quelles actions sont adaptées ? (2 réponses exactes)

Difficile - TD3 - médicaments et fragilité

- ☐ A. Déduire que l'absence de plainte signifie une guérison.
- ☐ B. Administrer sans contrôle parce que le médicament est de palier I.
- ☐ C. Évaluer l'éveil, la respiration et l'évolution récente.
- ☐ D. Attendre uniquement le prochain horaire de soin en cas de difficulté respiratoire.
- ☐ E. Sécuriser le risque de chute et clarifier une administration dont la sécurité est incertaine.

Q86 Quelles associations entre produit et vigilance sont pertinentes chez la personne âgée ? (3 réponses exactes)

Moyen - TD3 - médicaments et fragilité

- ☐ A. AINS : sécurité garantie par le palier I.
- ☐ B. Paracétamol : cumul quotidien, poids et nutrition.
- ☐ C. Néfopam : confusion, tachycardie et rétention urinaire.
- ☐ D. AINS : rein, hydratation, tube digestif et saignement.
- ☐ E. Paracétamol : absence de risque en cas de doublon.

Q87 Quelles actions composent un projet global de soin en douleur chronique ? (3 réponses exactes)

Moyen - Projet global et coordination

- ☐ A. Associer traitement prescrit et moyens non médicamenteux adaptés.
- ☐ B. Définir les rôles et coordonner les intervenants selon les besoins.
- ☐ C. Oublier le relais domicile ou institution dès que le score baisse.
- ☐ D. Réduire le plan à une succession de doses croissantes.
- ☐ E. Associer la personne et, avec son accord quand possible, ses proches.

Q88 Quelles affirmations décrivent le cercle d'entretien d'une douleur chronique ? (3 réponses exactes)

Difficile - Comprendre la douleur

- ☐ A. Le cercle dispense de rechercher une nouvelle cause organique.
- ☐ B. Douleur, fatigue et mauvais sommeil peuvent se renforcer.
- ☐ C. Peur du mouvement et évitement peuvent favoriser l'inactivité.
- ☐ D. Toutes les personnes passent obligatoirement par les mêmes étapes.
- ☐ E. L'activité adaptée et fractionnée peut aider à agir sur plusieurs maillons.

Q89 Que vérifier lors du relais ou de la sortie d'une personne traitée pour douleur ? (3 réponses exactes)

Moyen - Traçabilité et relais

- ☐ A. Les signes d'alerte et la conduite à tenir.
- ☐ B. Sa compréhension des prises, des associations et des horaires.
- ☐ C. Le suivi prévu et les objectifs fonctionnels.
- ☐ D. La simple remise d'une ordonnance suffit toujours.
- ☐ E. Une amélioration aujourd'hui rend tout suivi inutile.

Q90 Un effet indésirable médicamenteux est suspecté. Quelles propositions sont exactes ? (2 réponses exactes)

Moyen - Traçabilité et relais

- ☐ A. Une déclaration dispense de surveiller ensuite le patient.
- ☐ B. Un doute interdit toute transmission.
- ☐ C. La déclaration de pharmacovigilance ne remplace pas l'alerte ni la traçabilité.
- ☐ D. L'amélioration de la douleur suffit à éliminer un effet indésirable.
- ☐ E. Il faut prendre en charge la situation clinique et transmettre sans attendre une certitude de causalité.

Corrigés argumentés

Grille de réponses

Vérifier ensuite les justifications : chaque proposition est expliquée dans le corrigé.

Q01 D, E	Q31 A, D, E	Q61 B, C, D
Q02 A	Q32 B, D	Q62 A, B, C
Q03 B, C, D	Q33 B, D, E	Q63 A, B, E
Q04 B, E	Q34 A, D	Q64 B, C
Q05 D, E	Q35 A, B, D	Q65 B
Q06 E	Q36 A, B	Q66 B, E
Q07 C, D, E	Q37 B	Q67 C, E
Q08 A, E	Q38 A, B, D	Q68 A, C, D
Q09 D, E	Q39 A, C	Q69 A, B, C
Q10 C, E	Q40 A, C, E	Q70 C, D
Q11 C	Q41 A, E	Q71 A, C, E
Q12 A, B, C	Q42 A, E	Q72 B, E
Q13 A, D	Q43 D, E	Q73 A, C, D
Q14 A, D	Q44 C, D	Q74 C, D, E
Q15 A, C	Q45 B, C, E	Q75 E
Q16 D, E	Q46 C, D	Q76 B, C, D
Q17 C, D, E	Q47 D, E	Q77 C, D
Q18 A, C	Q48 A, B, C	Q78 D
Q19 C, D, E	Q49 A, E	Q79 A, C, E
Q20 A, C, D	Q50 B, E	Q80 C, D
Q21 B, E	Q51 A, B, E	Q81 A, C
Q22 D, E	Q52 A, B, E	Q82 A, C, D
Q23 A, C	Q53 B, C, D	Q83 A, E
Q24 B, D	Q54 A, C	Q84 C, D, E
Q25 C, D, E	Q55 C, D	Q85 C, E
Q26 A, C	Q56 A, D	Q86 B, C, D
Q27 A, C, D	Q57 B, D	Q87 A, B, E
Q28 B	Q58 C, E	Q88 B, C, E
Q29 B, C, E	Q59 B, D, E	Q89 A, B, C
Q30 A, B	Q60 B, D, E	Q90 C, E

Justification des propositions

Q01 Quelles affirmations décrivent la douleur ? (2 réponses exactes)

Réponses exactes : D, E

A - Faux : Le récit et une évaluation adaptée sont nécessaires.

B - Faux : Le contexte et plusieurs mécanismes influencent son intensité.

C - Faux : L'expérience douloureuse est personnelle.

D - Vrai : Ces dimensions font partie de sa définition.

E - Vrai : L'absence de lésion objectivée ne réfute pas l'expérience vécue.

Q02 Quelle proposition distingue la nociception de la douleur ? (1 réponse exacte)

Réponses exactes : A

A - Vrai : Elle ne résume pas toute l'expérience personnelle.

B - Faux : D'autres mécanismes peuvent intervenir sans plaie.

C - Faux : Les deux notions sont distinctes.

D - Faux : La peur appartient au vécu émotionnel et cognitif.

E - Faux : Un processus nerveux n'est pas une mesure de l'expérience.

Q03 Quels éléments explorent la composante sensorielle de la douleur ? (3 réponses exactes)

Réponses exactes : B, C, D

A - Faux : Il appartient surtout à la composante cognitive.

B - Vrai : Elle précise le territoire douloureux.

C - Vrai : Elle décrit l'importance ressentie dans un contexte donné.

D - Vrai : Les qualificatifs décrivent la qualité de la douleur.

E - Faux : Elle explore surtout le vécu émotionnel et les représentations.

Q04 À propos des composantes émotionnelle et cognitive, quelles affirmations sont justes ? (2 réponses exactes)

Réponses exactes : B, E

A - Faux : Les expériences antérieures peuvent moduler une douleur réelle.

B - Vrai : Elle doit être accueillie sans minimiser la douleur.

C - Faux : Le score décrit principalement l'intensité.

D - Faux : L'émotion ne détermine pas à elle seule la gravité somatique.

E - Vrai : Ils influencent l'interprétation de la situation.

Q05 Un patient sourit malgré une EN à 8/10. Quelles attitudes sont adaptées ? (2 réponses exactes)

Réponses exactes : D, E

A - Faux : Le soignant ne corrige pas arbitrairement l'auto-évaluation.

B - Faux : La douleur est personnelle et les comparaisons sont trompeuses.

C - Faux : L'expression comportementale varie entre personnes et situations.

D - Vrai : Une expression souriante ne réfute pas l'intensité rapportée.

E - Vrai : Le score s'intègre à une évaluation globale.

Q06 Quel repère permet de parler de douleur chronique ? (1 réponse exacte)

Réponses exactes : E

A - Faux : La chronicité peut concerner plusieurs mécanismes.

B - Faux : Il n'est pas nécessaire d'attendre six mois.

C - Faux : La durée et le retentissement ne se réduisent pas à un seuil d'intensité.

D - Faux : Une maladie active peut entretenir une douleur chronique.

E - Vrai : C'est le repère courant de chronicité retenu dans la fiche.

Q07 Quelles propositions sur les responsabilités infirmières face à la douleur sont exactes ? (3 réponses exactes)

Réponses exactes : C, D, E

A - Faux : L'installation, l'écoute, l'évaluation et la surveillance restent possibles.

B - Faux : Les conditions du cadre autorisé doivent être respectées.

C - Vrai : L'IDE reste actif dans l'accompagnement et l'évaluation.

D - Vrai : Sa prise en compte concerne l'ensemble du parcours de soins.

E - Vrai : Le protocole ne se remplace pas par une adaptation improvisée.

Q08 Quelles propositions distinguent les mécanismes nociceptif et neuropathique ? (2 réponses exactes)

Réponses exactes : A, E

A - Vrai : Une plaie ou une inflammation en sont des exemples.

B - Faux : Une même intensité peut correspondre à différents mécanismes.

C - Faux : La durée ne définit pas le mécanisme.

D - Faux : Les facteurs psychologiques peuvent moduler tous les mécanismes.

E - Vrai : Elle peut avoir une origine centrale ou périphérique.

Q09 À propos de douleur nociplastique et de mécanismes mixtes, quelles affirmations sont exactes ? (2 réponses exactes)

Réponses exactes : D, E

A - Faux : Le projet peut être multimodal.

B - Faux : La douleur demeure réelle.

C - Faux : Les facteurs psychologiques influencent tous les mécanismes.

D - Vrai : Une lésion tissulaire ou somatosensorielle suffisante n'est pas objectivée pour l'expliquer.

E - Vrai : L'évaluation recherche leurs contributions possibles.

Q10 Une toilette déclenche une douleur prévisible. Quelles propositions sont adaptées ? (2 réponses exactes)

Réponses exactes : C, E

A - Faux : Le choix dépend du patient, du geste et du cadre prescrit.

B - Faux : Le terme décrit le contexte et non un mécanisme spécifique.

C - Vrai : Le contexte est celui d'un soin douloureux.

D - Faux : La prévisibilité renforce l'intérêt de l'évaluation.

E - Vrai : L'anticipation associe plusieurs moyens adaptés.

Q11 À quelle étape correspond la transformation d'un stimulus nocif en signal électrique ? (1 réponse exacte)

Réponses exactes : C

A - Faux : Elle relève du dossier de soins.

B - Faux : Il concerne la programmation d'une PCA.

C - Vrai : Elle se produit au niveau de la terminaison sensorielle.

D - Faux : Elle correspond à l'intégration consciente du vécu.

E - Faux : Elle décrit la fraction de médicament atteignant la circulation.

Q12 Quelles propositions décrivent le traitement du message nociceptif ? (3 réponses exactes)

Réponses exactes : A, B, C

A - Vrai : Elle agit à plusieurs niveaux.

B - Vrai : Des relais participent ensuite aux voies ascendantes.

C - Vrai : La perception n'est pas le rôle d'une seule terminaison périphérique.

D - Faux : Le trajet spinal est un relais important pour les territoires concernés.

E - Faux : Des mécanismes périphériques et médullaires existent.

Q13 Quelles caractéristiques des fibres Aδ et C sont exactes ? (2 réponses exactes)

Réponses exactes : A, D

A - Vrai : Leur conduction contribue à une douleur initiale plus vive.

B - Faux : Elles participent notamment à la nociception.

C - Faux : Ces catégories ne sont pas identiques.

D - Vrai : Elles peuvent participer à une douleur tardive et diffuse.

E - Faux : La temporalité de conduction ne pose pas ce diagnostic.

Q14 Quelles affirmations correspondent au modèle simplifié du gate control ? (2 réponses exactes)

Réponses exactes : A, D

A - Vrai : Cela peut diminuer la transmission nociceptive.

B - Faux : Une urgence doit être recherchée.

C - Faux : Une modulation du message ne traite pas forcément la lésion.

D - Vrai : L'effet reste dépendant du contexte.

E - Faux : Elles sont de grosses fibres myélinisées du tact.

Q15 Quelles affirmations sur la sensibilisation sont exactes ? (2 réponses exactes)

Réponses exactes : A, C

A - Vrai : La sensibilisation n'est pas seulement périphérique.

B - Faux : Elles font partie des médiateurs de sensibilisation.

C - Vrai : La réponse devient plus importante pour une stimulation donnée.

D - Faux : Elle peut exister dans des contextes tissulaires inflammatoires.

E - Faux : Elle peut avoir des mécanismes physiologiques.

Q16 Quelles propositions distinguent allodynie et hyperalgésie ? (2 réponses exactes)

Réponses exactes : D, E

A - Faux : Ils décrivent un mode de réponse à une stimulation.

B - Faux : Il s'agit au contraire d'une douleur provoquée.

C - Faux : La réponse douloureuse est augmentée.

D - Vrai : Le stimulus est normalement indolore.

E - Vrai : Le stimulus est déjà nocif ou douloureux habituellement.

Q17 Quelles propositions sur le réflexe de retrait sont exactes ? (3 réponses exactes)

Réponses exactes : C, D, E

A - Faux : Il contient les corps cellulaires sensitifs.

B - Faux : L'état moteur ou neurologique peut modifier cette réponse.

C - Vrai : La sortie motrice passe par la racine ventrale.

D - Vrai : Réponse motrice et expérience personnelle restent distinctes.

E - Vrai : Le circuit spinal organise une réponse protectrice.

Q18 Une douleur d'origine viscérale peut être ressentie dans une zone cutanée distante. Quelles propositions l'expliquent ? (2 réponses exactes)

Réponses exactes : A, C

A - Vrai : Il faut rechercher la source et le contexte clinique.

B - Faux : Un signe isolé ne suffit pas au diagnostic.

C - Vrai : Cette convergence contribue à une localisation ressentie à distance.

D - Faux : Ces mécanismes n'ont pas le même objet.

E - Faux : Les causes sont multiples et doivent être évaluées.

Q19 Quelles associations correspondent au mémo TILT ? (3 réponses exactes)

Réponses exactes : C, D, E

A - Faux : Dans TILT, I signifie intensité.

B - Faux : Le traitement est à rechercher mais ne remplace pas le type.

C - Vrai : Rechercher siège, irradiation et plusieurs sites.

D - Vrai : Recueillir les qualificatifs du patient.

E - Vrai : Préciser début, durée, rythme et évolution.

Q20 Que faut-il ajouter à TILT pour une évaluation globale ? (3 réponses exactes)

Réponses exactes : A, C, D

A - Vrai : Elles renseignent les dimensions émotionnelle et cognitive.

B - Faux : Le vécu individuel prime.

C - Vrai : Elles aident à comprendre efficacité et risques.

D - Vrai : TILT ne résume pas les conséquences quotidiennes.

E - Faux : Un qualificatif oriente sans prouver une cause.

Q21 Quelles affirmations décrivent l'échelle numérique ? (2 réponses exactes)

Réponses exactes : B, E

A - Faux : Elle mesure principalement l'intensité.

B - Vrai : Repos et mouvement peuvent donner des résultats différents.

C - Faux : Cela ne correspond pas à une EN rapportée par le patient.

D - Faux : Le mécanisme, le terrain et le cadre thérapeutique restent nécessaires.

E - Vrai : C'est une auto-évaluation d'intensité.

Q22 Quelles affirmations sur l'EVA sont justes ? (2 réponses exactes)

Réponses exactes : D, E

A - Faux : Certaines présentations utilisent cette expression.

B - Faux : Cette description correspond à une EVS.

C - Faux : Les outils et leurs conditions doivent être respectés.

D - Vrai : Le soignant mesure ensuite la position.

E - Vrai : Une mesure sur 100 mm n'est pas une simple EN renommée.

Q23 Quelles propositions sur les outils d'auto-évaluation sont exactes ? (2 réponses exactes)

Réponses exactes : A, C

A - Vrai : Elle ne demande pas simplement de choisir une humeur.

B - Faux : Humeur et intensité ne sont pas identiques.

C - Vrai : Il faut garder la même version pour le suivi.

D - Faux : La compréhension doit être vérifiée.

E - Faux : Les changements peuvent modifier l'interprétation.

Q24 Une personne âgée présente un trouble neurocognitif modéré. Quelles attitudes sont adaptées ? (2 réponses exactes)

Réponses exactes : B, D

A - Faux : Le contexte et les capacités comptent aussi.

B - Vrai : Les aides sensorielles peuvent améliorer la fiabilité de la réponse.

C - Faux : Son avis complète l'évaluation sans remplacer la parole accessible.

D - Vrai : Un trouble cognitif n'annule pas automatiquement toute capacité.

E - Faux : Les capacités restantes doivent être recherchées.

Q25 Quels domaines appartiennent à ALGOPLUS ? (3 réponses exactes)

Réponses exactes : C, D, E

A - Faux : Ils ne composent pas cette grille comportementale.

B - Faux : Ces paramètres ne sont pas des items d'ALGOPLUS.

C - Vrai : Elles comprennent les vocalisations pertinentes selon la grille.

D - Vrai : Ils constituent deux domaines observés.

E - Vrai : Ils complètent les cinq domaines.

Q26 Chez une personne âgée non communicante verbalement, quelles affirmations sur ALGOPLUS sont justes ? (2 réponses exactes)

Réponses exactes : A, C

A - Vrai : Le score doit être intégré à la situation clinique.

B - Faux : Les échelles ne sont pas interchangeables.

C - Vrai : Chaque item positif compte un point.

D - Faux : Une douleur peut être méconnue et l'évaluation doit être poursuivie si elle est suspectée.

E - Faux : Il évalue des signes comportementaux.

Q27 Quelles affirmations décrivent DOLOPLUS-2 ? (3 réponses exactes)

Réponses exactes : A, C, D

A - Vrai : Ils couvrent plusieurs aspects du comportement.

B - Faux : Il concerne la personne âgée ayant des troubles de communication.

C - Vrai : Le résultat reste à interpréter avec le contexte.

D - Vrai : Les items sont cotés selon la grille.

E - Faux : Il s'agit d'un autre type d'évaluation.

Q28 À propos d'ECPA, quelle proposition est exacte ? (1 réponse exacte)

Réponses exactes : B

A - Faux : Il s'agit d'une hétéro-évaluation structurée.

B - Vrai : L'outil explore des comportements dans le contexte du soin.

C - Faux : Le contexte avant le soin apporte une référence.

D - Faux : Ce n'est pas une échelle fondée sur cette seule constante.

E - Faux : Le formulaire et les consignes validés doivent être utilisés.

Q29 Quelles associations entre outils et situations sont cohérentes ? (3 réponses exactes)

Réponses exactes : B, C, E

A - Faux : Il dépiste une composante neuropathique et n'a pas cet usage.

B - Vrai : EVENDOL concerne notamment le jeune enfant ; FLACC s'utilise selon les situations de soin ou postopératoires.

C - Vrai : La durée et la situation orientent le choix.

D - Faux : C'est une hétéro-évaluation destinée à la personne âgée.

E - Vrai : Le choix dépend aussi du contexte de validation.

Q30 En réanimation, un adulte ne peut pas s'auto-évaluer. Quelles propositions sont adaptées ? (2 réponses exactes)

Réponses exactes : A, B

A - Vrai : Une observation structurée est nécessaire.

B - Vrai : Ventilation, sédation et protocole orientent le choix.

C - Faux : Une constante ne remplace pas une auto-évaluation.

D - Faux : La sédation ne garantit pas l'analgésie.

E - Faux : L'adaptation à la situation est indispensable.

Q31 Quels éléments appartiennent au DN4 complet ? (3 réponses exactes)

Réponses exactes : A, D, E

A - Vrai : Le questionnaire complet comporte aussi un examen.

B - Faux : Elle n'appartient pas au questionnaire.

C - Faux : Elle ne constitue pas un item du DN4.

D - Vrai : Ils font partie de l'interrogatoire.

E - Vrai : C'est l'un des items d'examen.

Q32 Quelles interprétations d'un DN4 complet sont correctes ? (2 réponses exactes)

Réponses exactes : B, D

A - Faux : Le DN4 ne mesure pas l'intensité.

B - Vrai : Il ne remplace pas le diagnostic.

C - Faux : Les dix items sont nécessaires à cette cotation.

D - Vrai : C'est un résultat de dépistage.

E - Faux : Le traitement reste dans le cadre autorisé.

Q33 Quelles conditions rendent une réévaluation interprétable ? (3 réponses exactes)

Réponses exactes : B, D, E

A - Faux : Une aggravation impose une évaluation immédiate.

B - Vrai : Cela limite les différences liées à l'instrument.

C - Faux : Cette comparaison ne prouve pas un effet sur le lever.

D - Vrai : Repos et mobilisation ne sont pas interchangeables.

E - Vrai : Une baisse du score ne résume pas le bénéfice clinique.

Q34 Quelle distinction entre délai d'action et intervalle entre prises est correcte ? (2 réponses exactes)

Réponses exactes : A, D

A - Vrai : Il dépend notamment du produit et de la voie.

B - Faux : Les cinétiques diffèrent.

C - Faux : Il ne remplace pas l'intervalle prescrit.

D - Vrai : Il reste lié à la prescription et à la spécialité.

E - Faux : La sécurité impose de réévaluer immédiatement.

Q35 Quels éléments rendent une transmission douleur exploitable ? (3 réponses exactes)

Réponses exactes : A, B, D

A - Vrai : Une heure prévue n'atteste pas une prise.

B - Vrai : Ils décrivent l'évaluation réalisée.

C - Faux : Les hypothèses doivent rester identifiées.

D - Vrai : L'équipe doit savoir quoi surveiller et quand réévaluer.

E - Faux : Cette trace est insuffisante pour un médicament.

Q36 Quelles propositions sur les voies et dispositifs sont exactes ? (2 réponses exactes)

Réponses exactes : A, B

A - Vrai : Le caractère cutané ne signifie pas absence d'effet général.

B - Vrai : Elle doit être adaptée à l'état du patient.

C - Faux : La rapidité d'effet impose aussi des contrôles.

D - Faux : Le RCP de la présentation précise les voies autorisées.

E - Faux : C'est un mode d'administration par pompe.

Q37 Quelle affirmation sur la biodisponibilité absolue est exacte ? (1 réponse exacte)

Réponses exactes : B

A - Faux : Les équivalences dépendent du médicament et du contexte.

B - Vrai : Le médicament est directement administré dans la circulation systémique.

C - Faux : Ce n'est pas la définition de la biodisponibilité.

D - Faux : Absorption et premier passage peuvent la réduire.

E - Faux : La notion est pharmacocinétique et plus générale.

Q38 Quelles vérifications complètent les cinq B avant un antalgique ? (3 réponses exactes)

Réponses exactes : A, B, D

A - Vrai : Les doublons peuvent entraîner un surdosage.

B - Vrai : Le bon produit doit aussi convenir au patient.

C - Faux : Elle ne remplace pas les vérifications du produit.

D - Vrai : La sécurité se poursuit après l'administration.

E - Faux : Une information incertaine demande clarification.

Q39 Quelles propositions sur les formes LI et LP sont justes ? (2 réponses exactes)

Réponses exactes : A, C

A - Vrai : Sa libération est prolongée.

B - Faux : La titration dépend d'une stratégie prescrite et de la cinétique.

C - Vrai : Écraser une forme LP peut modifier sa libération.

D - Faux : Ouverture et broyage ont des règles distinctes propres au produit.

E - Faux : Leurs cinétiques et usages diffèrent.

Q40 Quelles associations entre famille et exemple sont correctes ? (3 réponses exactes)

Réponses exactes : A, C, E

A - Vrai : Ce sont des opioïdes dits faibles.

B - Faux : C'est un antalgique central non opioïde.

C - Vrai : Ce sont des opioïdes forts.

D - Faux : Le palier classe des médicaments, pas l'expérience douloureuse.

E - Vrai : C'est un antalgique non opioïde.

Q41 Quelles propositions sur les associations antalgiques sont adaptées ? (2 réponses exactes)

Réponses exactes : A, E

A - Vrai : Une approche multimodale peut être pertinente.

B - Faux : Cette association demande une analyse et n'est pas un automatisme.

C - Faux : Des traitements spécifiques peuvent être nécessaires.

D - Faux : Le qualificatif faible n'annule pas les risques.

E - Vrai : Plusieurs spécialités peuvent partager une substance ou un effet.

Q42 Une personne a reçu 1 g de paracétamol trois fois, puis une association contenant 500 mg de paracétamol. Quelles affirmations sont justes ? (2 réponses exactes)

Réponses exactes : A, E

A - Vrai : Le nom commercial ne modifie pas la substance cumulée.

B - Faux : Toutes les sources de paracétamol s'additionnent.

C - Faux : La prescription, le terrain et les horaires doivent être vérifiés.

D - Faux : Le surdosage de paracétamol expose à une atteinte hépatique grave.

E - Vrai : Trois grammes plus un demi-gramme donnent 3,5 g.

Q43 Une personne fragile pèse 44 kg et mange peu. Quelles attitudes sont adaptées avant du paracétamol ? (2 réponses exactes)

Réponses exactes : D, E

A - Faux : Le poids et les autres risques doivent être pris en compte.

B - Faux : Ce n'est pas une dose universelle.

C - Faux : Des doublons et prises antérieures restent possibles.

D - Vrai : Un plafond général ne suffit pas pour ce terrain.

E - Vrai : Ces facteurs peuvent modifier les conditions d'utilisation.

Q44 Un surdosage de paracétamol est suspecté. Quelles propositions sont exactes ? (2 réponses exactes)

Réponses exactes : C, D

A - Faux : Elle est un antagoniste opioïde.

B - Faux : L'avis reste nécessaire quelle que soit la découverte tardive.

C - Vrai : Il ne faut pas attendre les signes hépatiques.

D - Vrai : Sa mise en œuvre relève du cadre de prise en charge.

E - Faux : Les manifestations peuvent être retardées.

Q45 Quels risques doivent être recherchés avant un AINS ? (3 réponses exactes)

Réponses exactes : B, C, E

A - Faux : Les règles et contre-indications sont propres au produit.

B - Vrai : Les interactions et doublons modifient le bénéfice-risque.

C - Vrai : Ulcère, saignement et associations à risque sont à rechercher.

D - Faux : Un non-opioïde peut provoquer des effets graves.

E - Vrai : Les prostaglandines participent à l'équilibre rénal.

Q46 Une personne prend de l'aspirine à faible dose avant une intervention programmée. Quelles affirmations sont adaptées ? (2 réponses exactes)

Réponses exactes : C, D

A - Faux : Un arrêt ne s'improvise pas.

B - Faux : L'effet antiagrégant participe au risque hémorragique.

C - Vrai : Il faut mettre en balance risques hémorragique et thrombotique.

D - Vrai : Une faible dose ne correspond pas uniquement à une recherche d'antalgie.

E - Faux : Il reste pertinent pour la sécurité.

Q47 Quelles propositions sur les présentations de néfopam sont exactes ? (2 réponses exactes)

Réponses exactes : D, E

A - Faux : Aucune conversion ne s'improvise.

B - Faux : Une forme orale dédiée ne modifie pas l'AMM de l'injectable.

C - Faux : Il ne remplace pas un opioïde pour cet objectif.

D - Vrai : Il ne se classe pas comme un opioïde faible.

E - Vrai : Voies et plafonds ne se transposent pas automatiquement.

Q48 Quelles données imposent une vérification particulière avant le néfopam ? (3 réponses exactes)

Réponses exactes : A, B, C

A - Vrai : Le risque convulsif figure dans les contre-indications concernées.

B - Vrai : Les effets anticholinergiques comptent dans le choix.

C - Vrai : Le terrain et les recommandations du RCP doivent être vérifiés.

D - Faux : Un antalgique non opioïde peut provoquer des effets centraux.

E - Faux : Tachycardie et autres effets nécessitent une vigilance adaptée.

Q49 Quelles affirmations sur le tramadol sont justes ? (2 réponses exactes)

Réponses exactes : A, E

A - Vrai : Il agit aussi sur les recaptures de sérotonine et noradrénaline.

B - Faux : C'est un opioïde qui expose à des risques respiratoires.

C - Faux : Présentation, âge et terrain modifient les règles.

D - Faux : Une stratégie médicale peut être nécessaire pour l'arrêt.

E - Vrai : Les interactions doivent être vérifiées.

Q50 Quelles affirmations concernant la codéine sont exactes ? (2 réponses exactes)

Réponses exactes : B, E

A - Faux : La codéine y est contre-indiquée.

B - Vrai : Le cumul de cette substance doit être calculé.

C - Faux : Le métabolisme et le terrain varient.

D - Faux : Une adaptation ne se fait pas sans cadre.

E - Vrai : La variabilité enzymatique peut modifier la réponse.

Q51 Quelles associations pharmacologiques sont correctes ? (3 réponses exactes)

Réponses exactes : A, B, E

A - Vrai : Elle peut être utilisée pour certains surdosages selon le cadre.

B - Vrai : Elle active principalement les récepteurs μ.

C - Faux : Elle les active au lieu de les bloquer.

D - Faux : Cet antidote est la N-acétylcystéine.

E - Vrai : Ce n'est pas une troisième famille pharmacologique.

Q52 Quelles surveillances sont importantes sous morphine ? (3 réponses exactes)

Réponses exactes : A, B, E

A - Vrai : Les effets indésirables ne sont pas seulement respiratoires.

B - Vrai : Fréquence, amplitude et vigilance aident à repérer une toxicité.

C - Faux : Elle ne décrit pas toute la ventilation ni la sédation.

D - Faux : Efficacité et tolérance doivent être évaluées séparément.

E - Vrai : Accumulation et interactions peuvent augmenter les risques.

Q53 Une personne sous opioïde est très somnolente et respire lentement. Quelles actions sont prioritaires ? (3 réponses exactes)

Réponses exactes : B, C, D

A - Faux : La sécurité respiratoire est prioritaire.

B - Vrai : Son action peut être plus courte que celle de l'opioïde.

C - Vrai : Bradypnée et baisse de conscience sont des signes de gravité.

D - Vrai : La conduite peut inclure la suspension de l'administration en cause.

E - Faux : Cela peut retarder la prise en charge d'une dépression respiratoire.

Q54 Quelles conditions correspondent à une PCA standard ? (2 réponses exactes)

Réponses exactes : A, C

A - Vrai : La PCA repose sur son contrôle du bolus.

B - Faux : Les adaptations restent dans le cadre prescrit ou autorisé.

C - Vrai : Le programme et le circuit sont vérifiés.

D - Faux : Elle ne doit pas se substituer à lui en PCA standard.

E - Faux : Il peut exister dans certains contextes mais n'est pas systématique.

Q55 Quelles propositions décrivent la période de verrouillage d'une PCA ? (2 réponses exactes)

Réponses exactes : C, D

A - Faux : Programmation erronée, accumulation et interactions restent possibles.

B - Faux : La surveillance demeure indispensable.

C - Vrai : Un grand nombre de demandes appelle une analyse clinique et technique.

D - Vrai : La pompe applique l'intervalle programmé.

E - Faux : Le réglage dépend de la prescription et du contexte.

Q56 Quelles affirmations sur les co-antalgiques sont exactes ? (2 réponses exactes)

Réponses exactes : A, D

A - Vrai : Leur emploi ne signifie pas forcément épilepsie.

B - Faux : Douleur, sommeil, fonction et tolérance doivent être suivis.

C - Faux : Ils peuvent agir sur un mécanisme douloureux réel.

D - Vrai : Leur emploi ne signifie pas forcément dépression.

E - Faux : Il peut être progressif et variable.

Q57 Quelles vigilances concernent gabapentine ou prégabaline ? (2 réponses exactes)

Réponses exactes : B, D

A - Faux : Fonction, vigilance et autres effets doivent être suivis.

B - Vrai : Ces effets peuvent favoriser les chutes.

C - Faux : Toute modification doit être encadrée.

D - Vrai : Des adaptations et précautions peuvent être nécessaires.

E - Faux : Une autre famille n'est pas dénuée d'effets graves.

Q58 Quelles propositions sur les traitements locaux et les co-antalgiques sont exactes ? (2 réponses exactes)

Réponses exactes : C, E

A - Faux : Son usage dépend d'indications précises.

B - Faux : Il doit être réévalué comme toute intervention.

C - Vrai : Le traitement est adapté à la situation.

D - Faux : Les mécanismes et indications doivent être distingués.

E - Vrai : Leurs indications ne sont pas universelles.

Q59 Que préparer avant un soin potentiellement douloureux ? (3 réponses exactes)

Réponses exactes : B, D, E

A - Faux : Une promesse irréaliste peut altérer la confiance.

B - Vrai : Une organisation préparée réduit les contraintes.

C - Faux : L'évaluation commence avant le soin.

D - Vrai : L'information et la participation font partie du soin.

E - Vrai : L'anticipation peut associer plusieurs moyens.

Q60 Pendant un soin, quelles attitudes sont adaptées ? (3 réponses exactes)

Réponses exactes : B, D, E

A - Faux : Il faut sécuriser et alerter selon la gravité.

B - Vrai : Une aggravation ne doit pas être banalisée.

C - Faux : Le refus et l'inconfort appellent une adaptation.

D - Vrai : La douleur et les préférences guident les ajustements.

E - Vrai : Cela préserve une possibilité de contrôle pour la personne.

Q61 Quelles propositions sur le MEOPA sont exactes ? (3 réponses exactes)

Réponses exactes : B, C, D

A - Faux : Il s'utilise chez un patient conscient en ventilation spontanée dans les situations indiquées.

B - Vrai : Le patient doit être adapté aux conditions d'emploi.

C - Vrai : L'efficacité et la tolérance sont réévaluées.

D - Vrai : Il contient 50 % de chaque gaz.

E - Faux : Le RCP et les conditions d'utilisation restent essentiels.

Q62 Avant un topique lidocaïne-prilocaïne, quelles vérifications sont nécessaires ? (3 réponses exactes)

Réponses exactes : A, B, C

A - Vrai : Le caractère local ne supprime pas les risques.

B - Vrai : Ces paramètres conditionnent la sécurité.

C - Vrai : Le produit et l'acte déterminent les modalités.

D - Faux : Le délai dépend de la spécialité et de l'indication.

E - Faux : Installation, information et observation restent nécessaires.

Q63 Quelles propositions décrivent des moyens non médicamenteux adaptés ? (3 réponses exactes)

Réponses exactes : A, B, E

A - Vrai : Une technique non médicamenteuse est aussi une intervention de soin.

B - Vrai : La préférence et l'accessibilité comptent.

C - Faux : Indications, compétences et préférences doivent être prises en compte.

D - Faux : Elles ne doivent pas masquer une urgence.

E - Vrai : Le choix dépend du terrain et du besoin.

Q64 Quelles affirmations sur placebo, nocebo et relation de soin sont exactes ? (2 réponses exactes)

Réponses exactes : B, C

A - Faux : Les effets contextuels et pharmacologiques peuvent coexister.

B - Vrai : Elle évite les promesses irréalistes.

C - Vrai : Ils peuvent favoriser ou défavoriser le soulagement ressenti.

D - Faux : L'accompagnement repose sur une information adaptée et honnête.

E - Faux : Une modulation du vécu ne réfute pas la douleur.

Q65 Quel objectif permet de suivre un bénéfice fonctionnel après chirurgie ? (1 réponse exacte)

Réponses exactes : B

A - Faux : Une absence d'évaluation ne mesure aucun bénéfice.

B - Vrai : L'objectif relie soulagement et activité observable.

C - Faux : Cela ne démontre pas une amélioration à la mobilisation.

D - Faux : Une sédation profonde peut être un signe de gravité.

E - Faux : L'objectif se construit selon la personne et la situation.

Q66 M. Martin est à J0 d'une chirurgie digestive. Il dit « ça va, j'ai surtout mal quand je bouge » et serre les dents au changement de position. Quelles interprétations sont justes ? (2 réponses exactes)

Réponses exactes : B, E

A - Faux : Il faut explorer ce qu'il décrit et observe.

B - Vrai : Le « ça va » n'annule pas la suite de son propos.

C - Faux : Une discordance apparente demande une exploration respectueuse.

D - Faux : Aucune intensité chiffrée n'est fournie dans ces données.

E - Vrai : Il complète l'entretien sans donner un score chiffré.

Q67 M. Martin dit que la douleur est « moins forte allongé » mais reste présente. Quelles propositions sont justes ? (2 réponses exactes)

Réponses exactes : C, E

A - Faux : Elle décrit d'abord sa répartition ou localisation.

B - Faux : Il décrit la qualité de la douleur.

C - Vrai : Ces informations complètent TILT.

D - Faux : Il faut savoir si la douleur disparaît réellement entre les épisodes.

E - Vrai : Continue ne signifie pas constante en intensité.

Q68 M. Martin souhaite aller aux toilettes et craint la douleur. Quelles actions sont adaptées ? (3 réponses exactes)

Réponses exactes : A, C, D

A - Vrai : Il faut limiter déplacement et contraintes sans l'abandonner.

B - Faux : La sécurité et l'état postopératoire doivent être évalués.

C - Vrai : La préparation doit rester compatible avec l'urgence du besoin.

D - Vrai : Autorisation, vigilance, vertiges et risque de chute comptent.

E - Faux : Les produits, voies et besoins diffèrent.

Q69 Après traitement, M. Martin rapporte 2/10 au repos et 6/10 au lever, contre 7/10 au mouvement auparavant. Quelles conclusions sont adaptées ? (3 réponses exactes)

Réponses exactes : A, B, C

A - Vrai : Le contexte comparable est celui du mouvement.

B - Vrai : La réévaluation guide la suite.

C - Vrai : Il faut suivre la fonction et la tolérance.

D - Faux : Cette valeur initiale n'est pas fournie.

E - Faux : Il compare à tort mouvement et repos.

Q70 Après chirurgie, une douleur devient brutale et croissante avec difficulté respiratoire. Quelles actions sont prioritaires ? (2 réponses exactes)

Réponses exactes : C, D

A - Faux : Une cause nouvelle doit être recherchée.

B - Faux : Elle ne remplace pas la prise en charge d'une urgence.

C - Vrai : Une complication ne doit pas être banalisée.

D - Vrai : Le contexte guide les mesures urgentes.

E - Faux : La dégradation exige une évaluation sans délai.

Q71 M. L. décrit des brûlures et décharges aux pieds, avec sommeil perturbé et marche diminuée. Quelles propositions sont adaptées ? (3 réponses exactes)

Réponses exactes : A, C, E

A - Vrai : Une plaie ou un déficit récent peut modifier la priorité.

B - Faux : Une cause nouvelle ou associée reste possible.

C - Vrai : Le retentissement contribue au projet de soin.

D - Faux : Le bilan clinique apporte d'autres informations.

E - Vrai : Les qualificatifs orientent sans prouver seuls le diagnostic.

Q72 Mme R., 86 ans, dit avoir mal depuis des mois. Son fils estime qu'elle « se plaint toujours ». Quelles attitudes sont adaptées ? (2 réponses exactes)

Réponses exactes : B, E

A - Faux : La fréquence des plaintes ne compare pas les intensités.

B - Vrai : L'entourage peut apporter un complément utile.

C - Faux : Le vieillissement ne justifie pas la banalisation.

D - Faux : Le proche ne remplace pas une parole accessible.

E - Vrai : Le récit de la personne reste central.

Q73 Mme Jeanne B., 82 ans, a une gonarthrose douloureuse depuis huit mois, habituellement cotée 4/10. Après une chute ce matin, le genou droit est coté 8/10. Quelles analyses sont justes ? (3 réponses exactes)

Réponses exactes : A, C, D

A - Vrai : Les deux temporalités coexistent.

B - Faux : L'intensité ne détermine pas seule le diagnostic.

C - Vrai : Le contexte de mesure reste nécessaire.

D - Vrai : La gonarthrose connue ne suffit pas à expliquer l'aggravation.

E - Faux : Un événement récent modifie l'évaluation.

Q74 Après la chute de Mme Jeanne B., quelles données sont utiles au recueil ? (3 réponses exactes)

Réponses exactes : C, D, E

A - Faux : Il ne décrit pas les conséquences de la chute.

B - Faux : L'état clinique et le cadre thérapeutique restent nécessaires.

C - Vrai : Ils modifient les risques après traumatisme.

D - Vrai : L'évaluation ne se limite pas au genou.

E - Vrai : Ces signes peuvent orienter l'urgence de l'avis.

Q75 Mme Jeanne B. ne peut pas prendre appui après sa chute et présente une forte douleur du genou. Quelle conduite est adaptée ? (1 réponse exacte)

Réponses exactes : E

A - Faux : Le changement aigu ne doit pas être banalisé.

B - Faux : Cela peut aggraver une lésion.

C - Faux : Le contexte au mouvement est différent.

D - Faux : Le traumatisme non évalué impose de la prudence.

E - Vrai : Une lésion traumatique doit être recherchée.

Q76 M. André L., 79 ans, a une lombalgie chronique à 6/10, dort mal, mange moins et a cessé la pétanque. Quelles dimensions faut-il explorer ? (3 réponses exactes)

Réponses exactes : B, C, D

A - Faux : Il ne décrit pas toutes les conséquences.

B - Vrai : Sommeil, fatigue, alimentation et évolution sont à préciser.

C - Vrai : Découragement, peurs, relations et sorties comptent.

D - Vrai : Activités quotidiennes et aides orientent le projet.

E - Faux : La perte d'intérêt impose une évaluation, pas un diagnostic automatique.

Q77 Quelles propositions distinguent les composantes de la douleur de ses conséquences ? (2 réponses exactes)

Réponses exactes : C, D

A - Faux : Les deux bilans sont complémentaires.

B - Faux : Les paliers classent des médicaments et ne sont pas ces dimensions.

C - Vrai : Ces composantes se complètent.

D - Vrai : Il faut explorer les conséquences dans la vie quotidienne.

E - Faux : Il n'évalue pas à lui seul les relations ou l'isolement.

Q78 Quel projet est le plus adapté à M. André L., qui souhaite retrouver des activités malgré sa lombalgie ? (1 réponse exacte)

Réponses exactes : D

A - Faux : Sa participation donne du sens au soin.

B - Faux : Une activité adaptée peut faire partie du projet global.

C - Faux : Il faut tenir compte des capacités et limites.

D - Vrai : L'objectif doit être observable et réaliste.

E - Faux : Le résultat n'est pas garanti.

Q79 Mme Madeleine P., 88 ans, habituellement calme, devient en quelques heures agitée, grimaçante aux mobilisations et moins communicante. Quelles interprétations sont adaptées ? (3 réponses exactes)

Réponses exactes : A, C, E

A - Vrai : Infection, inconfort ou traitements peuvent se mêler.

B - Faux : L'observation doit être complétée.

C - Vrai : Le changement aigu peut être un signal clinique important.

D - Faux : Une cause récente doit être recherchée.

E - Vrai : Le lien avec les mouvements et le changement habituel sont utiles.

Q80 Mme Madeleine P. répond « non, laissez-moi » à la toilette. Quelles démarches sont adaptées ? (2 réponses exactes)

Réponses exactes : C, D

A - Faux : Les observations doivent éviter des stimulations inutiles.

B - Faux : D'autres modalités peuvent être utilisées.

C - Vrai : La cotation s'appuie sur les observations et les consignes.

D - Vrai : Les capacités restantes doivent être recherchées.

E - Faux : Un refus peut exprimer douleur, peur ou inconfort.

Q81 Une vignette décrit agitation et grimaces de Mme Madeleine sans cotation complète d'ALGOPLUS. Quelles propositions sont justes ? (2 réponses exactes)

Réponses exactes : A, C

A - Vrai : Cela complète l'observation actuelle.

B - Faux : Cause, urgence et contexte restent à évaluer.

C - Vrai : Il faut observer et coter les items de la grille.

D - Faux : Une hétéro-évaluation suit ses propres consignes.

E - Faux : Les domaines ne se déduisent pas arbitrairement d'un résumé.

Q82 Quelles interventions relationnelles et environnementales peuvent aider Mme Madeleine ? (3 réponses exactes)

Réponses exactes : A, C, D

A - Vrai : L'environnement peut réduire l'inconfort.

B - Faux : Il faut rechercher la cause et adapter la conduite.

C - Vrai : Une consigne simple peut réduire l'incompréhension.

D - Vrai : Cela préserve un contrôle et une coopération possibles.

E - Faux : Ses capacités et choix accessibles restent à respecter.

Q83 Mme B., 84 ans, reçoit un « antalgique de palier I » dont le nom n'est pas donné. Elle a une insuffisance rénale et une somnolence. Quelles propositions sont adaptées ? (2 réponses exactes)

Réponses exactes : A, E

A - Vrai : Le palier ne donne pas la DCI ni les modalités.

B - Faux : Cette information n'est pas fournie.

C - Faux : La causalité doit être évaluée.

D - Faux : Les molécules ont des profils de risque différents.

E - Vrai : Interactions, doublons ou autre cause de somnolence sont possibles.

Q84 Chez Mme B., 84 ans, insuffisante rénale, peu alimentée et polymédiquée, quelles vérifications sont pertinentes ? (3 réponses exactes)

Réponses exactes : C, D, E

A - Faux : L'état clinique et les traitements peuvent avoir évolué.

B - Faux : Un terrain fragile nécessite un raisonnement individualisé.

C - Vrai : L'état actuel peut rendre une administration incertaine.

D - Vrai : Ils peuvent modifier le bénéfice-risque et les adaptations.

E - Vrai : Les prises hors dossier doivent aussi être recherchées.

Q85 Mme B. présente une somnolence inhabituelle avant l'administration prévue. Quelles actions sont adaptées ? (2 réponses exactes)

Réponses exactes : C, E

A - Faux : Une communication diminuée peut masquer la douleur.

B - Faux : Le palier ne garantit pas la sécurité actuelle.

C - Vrai : Une dégradation aiguë peut demander une alerte immédiate.

D - Faux : Une difficulté respiratoire exige une prise en charge urgente.

E - Vrai : La prise ne doit pas être automatique.

Q86 Quelles associations entre produit et vigilance sont pertinentes chez la personne âgée ? (3 réponses exactes)

Réponses exactes : B, C, D

A - Faux : La classification ne supprime pas les effets indésirables.

B - Vrai : Le risque hépatique et les adaptations doivent être vérifiés.

C - Vrai : Son usage demande une vérification du RCP et du terrain.

D - Vrai : Les associations peuvent accroître ces risques.

E - Faux : Le cumul peut provoquer un surdosage.

Q87 Quelles actions composent un projet global de soin en douleur chronique ? (3 réponses exactes)

Réponses exactes : A, B, E

A - Vrai : Le projet peut être multimodal.

B - Vrai : Les actions doivent être cohérentes et suivies.

C - Faux : La continuité du suivi reste nécessaire.

D - Faux : La fonction et le contexte demandent d'autres leviers.

E - Vrai : Participation et ressources guident le projet.

Q88 Quelles affirmations décrivent le cercle d'entretien d'une douleur chronique ? (3 réponses exactes)

Réponses exactes : B, C, E

A - Faux : Une aggravation demande toujours un raisonnement clinique.

B - Vrai : Le projet doit explorer ces interactions.

C - Vrai : Ces facteurs peuvent réduire les capacités et la confiance.

D - Faux : Le modèle décrit des influences possibles.

E - Vrai : Elle s'intègre à une stratégie personnalisée.

Q89 Que vérifier lors du relais ou de la sortie d'une personne traitée pour douleur ? (3 réponses exactes)

Réponses exactes : A, B, C

A - Vrai : Le patient doit savoir quand et comment demander un avis.

B - Vrai : Les erreurs de cumul doivent être prévenues.

C - Vrai : La réévaluation doit se poursuivre après la sortie.

D - Faux : La compréhension et l'organisation du relais doivent être vérifiées.

E - Faux : Le bénéfice et la tolérance peuvent évoluer.

Q90 Un effet indésirable médicamenteux est suspecté. Quelles propositions sont exactes ? (2 réponses exactes)

Réponses exactes : C, E

A - Faux : La surveillance et les soins restent nécessaires.

B - Faux : La suspicion est une information utile à signaler.

C - Vrai : Ce sont des démarches complémentaires.

D - Faux : Efficacité et toxicité peuvent coexister.

E - Vrai : La sécurité immédiate prime.